

28 - Maltraitance et sévices à enfants - Pr. AABBASSI

(0:01 - 0:24)

Bonjour, nous allons traiter ensemble aujourd'hui la maltraitance et les sévices à enfants. Au terme de ce cours, vous allez être capable de définir la maltraitance, de détecter les situations à risque, d'évaluer correctement un enfant flexible de maltraitance, de prendre en charge précocement un enfant en situation de maltraitance. Nous allons adopter le plan suivant.

(0:28 - 1:15)

L'OMS définit la maltraitance comme étant toute forme de mauvais traitement physique ou affectif, de sévices sexuels, de négligence ou de traitement négligent, ou d'exploitation commerciale ou autre, entraînant un préjudice réel, ou même potentiel pour la santé de l'enfant, sa survie, son développement ou sa dignité, dans le contexte d'une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir. C'est-à-dire, un ensemble de mauvais traitements, qu'ils soient physiques, affectifs, sexuels, ou même des négligences de soins, qui va être exercé sur l'enfant, un mineur, de la part d'un adulte qui prend soin de lui, ou qui est responsable de lui. On entend par enfant, tout enfant et adolescent inférieur à 18 ans.

(1:15 - 1:41)

Il y a l'enfant maltraité, qui est déjà victime de maltraitance, et un enfant à risque de maltraitance, dont les conditions d'existence l'exposent à un risque futur de maltraitance. Les sévices sont les mauvais traitements corporels exercés sur quelqu'un qu'on a sous son autorité ou sous sa garde. À partir de la définition de maltraitance, nous constatons que c'est un champ qui est très vaste, à limite de flots.

(1:41 - 1:58)

C'est la clinique du réel, c'est-à-dire les signes cliniques, vous allez les observer. Un manque de soins, des vêtements qui sont sales, des coups, vous allez les voir, des griffes, vous allez les voir. C'est une situation qui définit un problème majeur de santé publique, de par sa fréquence, de par ses conséquences.

(1:59 - 2:25)

Il y a tout un dispositif de prise en charge bien élaboré sur le plan médical, social et judiciaire. Ce sont des situations qui mettent en jeu le pronostic de développement de l'enfant. Ce pronostic fonctionnel est parfois vital, qui peut donner aussi des séquelles physiques et psychologiques désastreuses, d'où tout l'intérêt de la prévention, qui est un droit de l'enfant, un devoir de la société et une responsabilité du médecin.

(2:25 - 3:15)

Les chiffres sont imprécis, mais ils sont très alarmants. Maintenant, qu'en est-il de l'ithiopathogénie ? Il y a des facteurs de risque. Il y a l'enfant à risque, il y a l'adulte à risque, il y a les familles à risque, il y a les circonstances particulières.

(3:15 - 3:26)

L'enfant à risque, généralement, ce sont les filles qui sont plus maltraitées et plus violentées que les garçons. C'est un enfant adultérien, par exemple. C'est un enfant qui est produit d'une relation hors mariage.

(3:26 - 3:36)

C'est un enfant malade physique ou mental. C'est un enfant prématuré. L'adulte à risque, c'est des parents qui sont en deuil, qui sont séparés, qui ont eux-mêmes subi de la maltraitance.

(3:37 - 3:51)

Un parent qui est déprimé, en instabilité affective, qui est addict à l'alcool ou aux drogues. Ou les parents qui sont en conflits conjugaux. Ils sont les plus susceptibles de violenter ou de maltraiter leur enfant.

(3:52 - 4:06)

Les familles à risque sont des familles isolées, monoparentales, mal recomposées ou en situation socio-économique difficile. Quelques circonstances particulières. On peut voir de la maltraitance suite à une grossesse non désirée ou suite à une mort périnatale.

(4:10 - 4:21)

La maltraitance prend différentes formes. Il y a la maltraitance physique, de l'ordre de coups, de gifles, d'hématomes, de brûlures et de greffures. La maltraitance psychologique, le dénigrement ou le rabaissement de l'enfant.

(4:21 - 4:32)

Le chantage affectif, le rejet, la menace et l'abandon. Par exemple, tu ne vauds rien, je ne t'aime pas. Soit tu me fais ça, je vais t'aimer et donc je vais prendre soin de toi.

(4:32 - 4:46)

Si tu ne fais pas ça, je ne t'aime pas et je vais te frapper et te violenter. La maltraitance sexuelle se définit comme tout acte que commet un tuteur sur la personne d'un enfant pour en retirer un plaisir sexuel. Ce n'est pas limité à la pénétration et au viol.

(4:47 - 5:02)

Il même les attouchements et le contact physique non consentant, c'est à dire sans l'accord de l'enfant, sont de l'ordre de la maltraitance sexuelle. La négligence, c'est un manque ou un défaut de soins. Des soins élémentaires comme lui préparer à manger, comme nettoyer ses vêtements par exemple.

(5:05 - 5:16)

Quels sont les effets de la maltraitance ? En immédiat, la maltraitance donne un impact émotionnel sur l'enfant. De l'ordre de la peur, de la terreur, de la tristesse. Ça donne aussi un impact relationnel.

(5:16 - 5:31)

L'enfant y va soit éviter les relations, soit rechercher de la proximité ou une alternance entre les deux. Tantôt il est très proche de vous, tantôt il s'éloigne. Ça peut donner aussi à l'adolescence et à l'âge adulte des troubles de conduite et des troubles anxio-dépressifs.

(5:35 - 5:47)

On va déployer quelques situations cliniques fréquentes de maltraitance. On commence par le bébé secoué. C'est un bébé qui est secoué par un adulte suite à une crise de pleurs.

(5:47 - 6:05)

Par exemple, le bébé a besoin de téter et il a faim. Ou il a besoin d'être lavé, de changer ses couches par exemple. Il est en train de pleurer.

Ça provoque l'adulte. Il va le secouer. C'est une forme qui est très courante de violence et qui va toucher les enfants de moins de 9 mois.

(6:05 - 6:32)

L'auteur principal est décrit dans la littérature comme étant de sexe masculin. Généralement, c'est le papa. Comme vous voyez sur l'image d'en haut, si l'on secoue vivement un nourissant, on risque de provoquer chez lui par ces mouvements-là des hémorragies intracrâniennes, des hémorragies rétinienne et des petites fractures des principales articulations des extrémités ou même, en le secouant, on peut lui donner un point d'impact crânien lorsqu'il va cogner sa tête sur une surface.

(6:33 - 8:25)

Les deux tiers de ces nourrissons malheureusement vont mourir et la majorité, à long terme, y vont garder un retard mental, une infirmité motrice cérébrale ou une cécité. L'autre forme la plus fréquente est la maltraitance sexuelle. C'est une violation grave, on est bien d'accord des droits

de l'enfant.

Comment ça va se manifester ou comment vous allez penser à ça ? C'est un enfant qui va présenter des signes physiques ou des comportements atypiques. Mais la particularité, c'est qu'ils ne sont pas spécifiques. Par exemple, les problèmes physiques.

Il peut avoir des symptômes d'infection, de traumatisme de l'appareil génital mais ce n'est pas spécifique. Vous pouvez voir des vulvites banales, par exemple, dans le cadre d'une oxyrose, des maux de tête qui sont récurrents, des douleurs abdominales, de la constipation ou des infections urinaires chroniques et récurrentes. L'important, c'est de penser s'il y a des circonstances particulières de l'enfant, un enfant à risque, une situation familiale à risque avec des signes physiques comme ce que je viens de vous détailler, vous devez penser à la maltraitance sexuelle.

Sinon, il y a les signes comportementaux. L'enfant qui va s'isoler volontairement, qui ne va pas raconter ses journées, il se désintéresse de ce qu'il aime habituellement, il semble avoir peur, il refuse d'aller seul quelque part, ses résultats scolaires se dégradent, il refuse la tendresse, la proximité physique, il ne veut pas se mettre nu devant un adulte, il régresse, c'est-à-dire qu'il va parler comme un bébé, qu'il va sousser son pouce, qu'il va mouiller son lit. Il aura de l'insomnie, de la perte de l'appétit, il fait des cauchemars la nuit, il aborde des sujets sexuels, il va s'intéresser de façon très curieuse à tout ce qui est sexualité, il va poser des questions, il va faire des dessins qui vont paraître aux parents très explicites, ou un comportement de séduction, il va même mimer des jeux sexuels, ou il va se masturber, ou il va mimer des bruits sexuels en public.

(8:26 - 8:51)

Normalement, ça doit tilter dans l'esprit et vous faire penser à la maltraitance sexuelle. Sachez que beaucoup d'enfants vont confier spontanément les faits de maltraitance aux personnes qui vont s'occuper d'eux, mais dans l'autre versant, il y a des enfants qui vont rester dans le silence, soit par peur, soit par honte et culpabilité, soit parce qu'ils vont protéger l'agresseur qui est souvent un proche. Nous avons vu que ça peut être les parents.

(8:52 - 9:32)

Ou, pour les tout petits enfants, ils vont croire que c'était juste un jeu avec un adulte. Ceux-ci, ces situations de silence, je veux bien dire, ils vont nous compliquer la tâche parce que cet enfant peut être sujet à une maltraitance chronique. La partie pratique, comment vous allez évaluer un enfant victime de maltraitance.

L'évaluation commence déjà depuis l'accueil, par une présence calme du médecin qui est rassurante et écoute bienveillante. On va le recevoir seul et avec son accompagnateur. Gardez à l'esprit que l'accompagnateur peut être l'auteur ou le témoin passif des faits.

(9:33 - 9:54)

Le lieu doit être adapté et calme. Un lieu sûr et un lieu sécurisé et un lieu confidentiel. N'examinez pas ces situations dans le couloir ou dans des bureaux où il y en a plusieurs autres personnes.

On doit être dans la confidentialité. On va tenir un dossier médical, c'est-à-dire qu'on va noter. On doit mettre un dossier médical.

(9:55 - 10:20)

On doit noter les dires de l'enfant, les observations et les signes cliniques. Tout ça doit être bien noté sur votre dossier médical parce qu'il y a un aspect médico-légal de la situation qu'on va voir un peu plus tard. L'anamnèse, on va restituer les faits, la nature des faits, c'est quel type de maltraitance, la fréquence des faits, est-ce que c'est une seule fois ou c'est réitérant, est-ce que c'est chronique, les dates si on peut les avoir, les lieux de ce qui vient de se passer.

(10:21 - 11:27)

On va rechercher les signes physiques et comportementaux. On va redresser l'histoire familiale et parentale justement pour chercher, est-ce qu'il y a de la maltraitance transgénérationnelle, est-ce qu'il y a une situation à risque de maltraitance, comme on a vu un peu plus tôt. Le fonctionnement de l'enfant et de son entourage, est-ce qu'il y avait une rupture dans le fonctionnement de l'enfant? Nous avons vu que ça peut donner des fléchissements de résultats scolaires, un changement de comportement, des modifications de l'humeur.

Donc ça, c'est tout à noter. Et l'entourage, c'est-à-dire la réaction de l'entourage face à ça. Parfois, face à une maltraitance, on devient maltraitant.

Les parents, parce qu'ils sont en colère, parce qu'ils sont hérités par ces situations, ils peuvent frapper l'enfant. Tu n'étais pas victime, mais tu as provoqué ça, tu as été entre guillemets, auteur de cette violence. Je parle de violence sexuelle, par exemple, c'est parce que tu as mis ces vêtements, c'est parce que tu es parti à ce lieu-là.

Donc, ils peuvent maltraiter l'enfant encore plus. L'examen clinique doit être complet et minutieux. On commence par un examen cutaneo-muqueux.

(11:28 - 13:02)

Notera qu'il y a l'existence d'hématomes, d'échymoses, d'alopécies, de brûlures, de fractures dentaires, de plaies gingivales. Un examen ophtalmologique, décollement de rétine ou hémorragie subconjonctivale. Un examen ORL, par exemple, des tympons qui sont lésés.

Examen abdominale, qui est une défense, une sensibilité. L'examen osseux, les points douloureux et les fractures et l'examen génital et l'anus sont à faire systématiquement, il ne

faut pas les oublier. Vous notez tout ça en notant le siège, le nombre et l'anxiété des lésions.

Les lésions doivent être photographiées ou reproduites sur un schéma. Donc, pour qu'on garde à l'esprit le premier examen, qu'est-ce qu'il a donné qu'on produit ? Parce qu'il y a des lésions qui peuvent s'effacer avec le temps. On peut s'aider parfois, pas toujours, de bilan paraclinique selon les situations.

On peut demander un bilan des moustaches, cas d'hémorragie, par exemple, des prélèvements de sperme, d'ADN, des sérologies, des IST, des bilans radiologiques, de l'ordre de l'échographie abdominale, une TDM cérébrale, des radiologiques en entier. Il y a quelques lésions qui sont caractéristiques. Lorsque vous allez les voir sur les clichés, vous allez être orienté vers la maltraitance ou c'est un faisceau d'arguments encore plus que vous êtes dans une situation de maltraitance, comme les fractures de l'arc postérieur et moyen des côtes chez le nourissant, les fractures de crâne et les fractures par torsion.

Question essentielle est de poser le diagnostic positif et d'écarter les diagnostics différentiels. Nous avons bien vu que les signes ne sont pas spécifiques. Il peut s'agir d'une ville vide banale par exemple, d'une malformation ou d'un traumatisme accidentel.

(13:02 - 13:31)

L'enfant est joué et puis il est tombé dans les escaliers et il a eu une fracture. Est-ce que c'est une fracture par accident ou c'est une fracture par maltraitance? On peut bien se poser cette question. Le diagnostic positif repose sur l'association de signes, sur la répétition des lésions dans le temps, sur le siège multiple ou inhabituel et aussi sur le sentiment que vous avez éprouvé de malaise par rapport à des situations qui ne sont pas habituelles, qui sont douteuses.

(13:35 - 14:03)

L'aboutissement de l'évaluation clinique est la rédaction de certificat de constatation médicale. C'est un document qui doit être clair, descriptif, simple, signé et daté. Vous allez mettre votre nom, le nom de l'enfant, sa date de naissance, il a été accompagné par qui, vous allez noter les dires de l'enfant, vous allez noter les signes cliniques que vous avez relevés, les résultats des bilans que vous avez demandés et vous signez en notant la date et le lieu de l'examen.

(14:06 - 14:46)

Maintenant, comment prendre en charge l'enfant victime de maltraitance? Toujours garder à l'esprit que notre action doit prendre en compte l'intérêt prépondérant de l'enfant. On est là pour protéger l'enfant, pour lui assurer ses droits. Donc, on doit agir de façon précoce, comme on l'a dit, confidentielle.

Il nous semble à plusieurs. Il y a le médecin, il y a les équipes spécialisées, par exemple les équipes de chirurgie, ou il y a l'équipe pédopsychiatrique, les autorités judiciaires et

administratives, l'assistante sociale et dans les meilleurs des cas, la famille aussi, s'il est collaboratrice avec nous. La prise en charge commence par l'accueil.

(14:46 - 15:07)

On va accueillir ou soit en ambulatoire, dans des consultations, des urgences, des consultations de soins ambulatoires générales, pédiatriques ou autres, ou dans un milieu hospitalier. On va hospitaliser l'enfant pour le protéger s'il y a un danger caractérisé, c'est-à-dire que la violence est d'origine familiale, que les parents sont très violents et qu'on sent que l'enfant ne sera pas en sécurité. On va l'hospitaliser.

(15:07 - 15:22)

Ou, par exemple, si on veut compléter le diagnostic et instaurer le traitement. Ça peut se faire au service des urgences, au service de pédiatrie ou au service de pédopsychiatrie. Signaler est une étape importante dans la prise en charge des enfants victimes de maltraitance.

(15:23 - 15:47)

Signaler veut dire alerter une autorité compétente sur la situation de danger dans laquelle se trouvent l'enfant et l'adolescent. Protéger l'enfant est essentiel, on n'est pas là pour faire une enquête ou désigner un coupable, ce n'est pas notre rôle. Ça se fait par un document clair, descriptif, signé et daté que vous allez garder en double et que vous allez envoyer en recommandé avec un accusé de réception.

(15:47 - 16:30)

C'est le certificat de constatation médicale que nous avons vu un peu plus tôt. Vous allez l'adresser à qui ? Aux autorités judiciaires, le procureur de droit, la police, la gendarmerie, ça dépend du lieu de votre exercice, ou aux autorités administratives si l'enfant ou l'adolescent est dans un centre d'accueil ou à l'école. L'aspect médico-légal c'est que votre action est régie par plusieurs articles de code pénal et de déontologie.

L'article 44 du code de déontologie médicale qui impose aux médecins de protéger le mineur et de signaler les civils dont il est victime. Donc vous êtes dans l'obligation de signaler. L'article 226-14 du code pénal qui va vous délier du secret professionnel.

(16:30 - 17:28)

On n'est pas dans une situation de secret professionnel. Normalement le médecin, son action est régie par le secret professionnel entre lui et son patient et dans le cas d'enfant avec le tuteur. Maintenant on est dans une situation où on est délié du secret professionnel.

On a une tierce personne qu'on peut alerter qui est le procureur de droit ou les autorités

judiciaires. Puis l'article 431 qui est de la non-assistance à une personne en danger. Une personne qui n'assiste pas à une personne en danger encourt une peine d'emprisonnement ou une amende.

Maintenant on voit à la partie traitement. Donc soit on va procurer à cet enfant des soins médicaux et chirurgicaux, des soins locaux, des plâtres, des antibiotiques lorsqu'il y a une infection, des interventions chirurgicales par exemple s'il y a des fractures qui sont ouvertes ou il y a de la défense parce qu'il y a un traumatisme par exemple de foie ou un traumatisme abdominal quelque part. Puis il y a les soins psychiatriques.

(17:28 - 18:59)

On va recevoir ces enfants dans des équipes pédopsychiatriques par les psychologues ou par les pédopsychiatres pour des psychothérapies parce que ça donne des réactions psychiques de l'ordre de la dépression, de l'anxiété, des états de traumatisme. Donc on va l'accueillir en psychothérapie soit individuelle soit de groupe. La psychothérapie familiale aussi.

On peut prescrire selon les symptômes des médicaments, les hypnotiques ou les somnifères lorsqu'il y a des troubles de sommeil, les neuroleptiques par exemple s'il y a des troubles de comportement de l'autre, de l'anxiété qui est excessive ou de l'agitation ou des antidépresseurs dans les troubles anxieux avérés et dans les états dépressifs. Une situation de maltraitance qui n'est pas prise en charge correctement expose l'enfant à des séquelles neuromusculaires irréversibles, à des atteintes durables de développement psycho-affectif et cognitives qui peuvent aller même vers un retard mental de l'ordre carenciel parce qu'il n'y a pas de stimulation, parce qu'il n'y a pas d'expérience et d'apprentissage que l'environnement va donner à l'enfant. On peut avoir un retard mental du décès, donc des coups qui peuvent être mortels par exemple, du suicide, de l'agressivité envers lui-même ou vers l'autre, à l'échec scolaire ou difficultés relationnelles et désinsertions, un peu plus tard à la délinquance, à la criminalité, à la prostitution, à l'abus d'alcool et de drogue ou les répétitions transgénérationnelles, c'est-à-dire que cet enfant à l'âge adulte va être lui-même un auteur de maltraitance envers les enfants.

(19:04 - 19:30)

Ceci nous marque que c'est une situation qui est sérieuse, qui est sévère et donc on peut agir en amont, c'est-à-dire qu'on peut prévenir. La prévention primaire, c'est qu'on va faire des bilans de santé réguliers pour tous les enfants, aussi bien de santé physique que de santé mentale et développementale. C'est dans les consultations d'enfance qu'on va chercher ce qu'il y a des facteurs de risque, enfant à risque, adulte à risque, situation à risque, famille à risque.

(19:30 - 20:45)

On va garder un œil sur cet enfant qui est à risque de maltraitance. On va faire des actions de sensibilisation et d'information aux crèches, aux écoles. On va apporter de l'aide sociale et

éducative aux familles qui s'en diminuent Ou la prévention secondaire, c'est-à-dire l'enfant il est maltraité, oui, donc je dois le prendre en charge précocement de façon globale et adaptée.

La prévention tertiaire, c'est-à-dire que c'est un enfant qui est maltraité et qui a des séquelles, donc je vais prendre en charge ses séquelles développementales, physiques et mentales. Voilà, donc la maltraitance est une menace sévère au développement sain de l'enfant. C'est une situation fréquente mais souvent sous-estimée parce qu'il y a du silence, parce qu'il y a du déni et de la dissimulation.

Silence de la part de l'enfant, silence de la part de son entourage parce que c'est honteux, il y a du déni, il n'y a rien, pour protéger l'agresseur qui est un membre de la famille, la dissimulation à un accident domestique tout à fait normal. Donc tout l'intérêt pour nous, médecins, acteurs, de la chercher activement devant toute situation douteuse, de l'évaluer correctement, de la signaler, de protéger l'enfant et de prévenir les séquelles qui peuvent s'installer tout au long du développement de l'enfant.